

2

骨髄抑制・FN:薬剤師の実践ポイント

感染予防指導とG-CSF適正使用

1 服薬指導で伝えるポイント



37.5℃以上の発熱は自己判断せず「すぐ連絡」を徹底するよう繰り返し伝える



nadir時期(投与後1~2週間)は人混みを避け、手洗い・うがいを徹底するよう伝える



体温を測る習慣と、発熱時の連絡先(夜間・休日含む)を事前に共有しておく

2 処方監査・疑義照会のタイミング

- ☐ 高リスクレジメン(FN発現率20%以上目安)で一次予防的G-CSFが処方されていない場合、処方医への確認を検討する
- ☐ G-CSF投与のタイミング(化学療法後24時間以降)が守られているか確認する
- ☐ 抗菌薬併用時は、骨髄抑制を助長しうる薬剤(ST合剤等)との重複がないか確認する

3 施設間連携・情報共有のポイント



発熱時の受診先(夜間休日対応可能な医療機関)を患者さんと事前に確認しておく



血液検査値(好中球数)の推移を、お薬手帳等を通じて経時的に把握する

4 実践チェックリスト

- ☐ 初回投与前に、nadir時期の目安と発熱時対応を必ず説明する
- ☐ G-CSF自己注射がある場合は手技指導・保管方法を確認する
- ☐ 発熱の連絡を受けた際は、自己判断せず速やかな受診を案内する

発熱性好中球減少症は「知っていれば防げる重症化」。患者さんへの事前説明の徹底が最大の武器になる。